

消化管局在、粘膜損傷、閉塞、出血、炎症制御

口腔咽頭性嚥下障害

- 不顕性誤嚥があり得る
- 嚥下造影や内視鏡評価で方略を試す
- 食形態変更は誤嚥も水分も減らす
- 実際の食物で方略を試す
- 経管栄養は誤嚥を完全に防がない
- 口腔ケアは誤嚥される菌量を減らす
- 湿性嚔声、食事時咳、反復肺炎
- 無期限処方せず再評価
- むせがなくても安全とはしない

胃粘膜損傷

- 粘液・重炭酸層、緊密上皮、血流
- 非ステロイド性抗炎症薬は全身作用と局所作用
- ヘリコバクター・ピロリは粘液ニッチで炎症
- ディスペプシアだけでは潰瘍を同定できない
- 併存は潰瘍リスクを著増

ディフィシル疾患とセリアック病

- 抑制薬は検査の偽陰性を作る
- 定着抵抗性喪失と毒素性大腸炎
- 適合症候群の非成形便だけ検査
- 核酸検出は毒素損傷を証明しない
- 劇症型は早期外科評価
- セリアック病は鉄欠乏だけのことも
- グルテン摂取中に血清検査
- 検査前除去食は粘膜を治し診断を隠す

炎症性腸疾患

- カルプロテクチンは炎症を示し原因は示さない
- 粘膜治癒後も症状が続き得る
- 急性重症潰瘍性大腸炎は全身救急
- 入院、静注糖質コルチコイド、血栓予防、外科
- 数日以内に反応を評価
- 失敗なら救済療法が結腸切除

閉塞と腸間膜虚血

- オピオイドと抗コリン薬は拡張を悪化
- 外科相談を遅らせない
- 上流に液・ガスが貯まる
- 蠕動が障害へ働き疝痛性となる
- 持続痛とアシドーシスは絞扼を示唆
- 減圧は病変を除かない
- 鎮痛を抑えない
- 非手術管理は虚血徴候がない場合のみ
- 虚血は診察以上の強い腹痛
- 心房細動、動脈硬化、低流量ショック
- 正常な乳酸でも安心できない

管腔に沿った局在

- 管腔内容物の経路を追う
- 嚥下開始は口腔、咽頭、脳神経
- 胸骨後つかえは食道通過
- 嘔吐は近位推進不全か中枢刺激
- 膨満と排便・排ガス停止は遠位閉塞
- 同じ症状が複数高位で起こる
- 解剖、時期、内容、生理的結果を合わせる

食道性嚥下障害と逆流

- 固形物から進む困難は管腔狭小
- 発症から固形・液体双方なら運動障害
- アカラシアは弛緩しない括約筋上に貯留
- 症状は酸曝露と常に一致しない
- プロトンポンプ阻害薬は食前に最も働く
- 警告所見で内視鏡診断へ移る
- 癌、消化性狭窄、輪、好酸球性炎症
- 夜間逆流と誤嚥

上部消化管出血

- 診断前に循環・気道問題
- 初期ヘモグロビンは正常なことがある
- 輸血は一閾値でなく個別化
- リスク分類は進行出血を上書きしない
- 再出血は再内視鏡、塞栓、手術
- 抗凝固の再開は能動的に決める
- 静脈瘤は内視鏡前に血管作動と抗菌薬
- 平衡前に全血を失う
- 過剰は門脈圧を上げる
- 不足は心・脳を傷つける

下痢と補水

- 浸透圧性は絶食で減る
- 分泌性は絶食中も続く
- 経口補水はナトリウム・グルコース共輸送
- 毒素症候群では抗菌薬が害となる
- 推定欠乏と継続喪失を分ける
- 血便や発熱では腸運動抑制薬を避ける
- 水だけではナトリウム喪失を補えない
- 高濃度甘味飲料は浸透圧性下痢を悪化

便秘、肛門直腸出血、最終記録

- 便秘は排便頻度だけではない
- 便塞栓周囲の溢流性下痢
- 肛門直腸出血は視診・診察する
- 症状制御と脅かされた腸を区別
- 高位、機序、容量、危険を記録
- 悪化が続けば症状改善は治癒でない